

13 - 7 Annonce d une mauvaise nouvelle

Chers étudiants, j'ai le plaisir de vous présenter encore une fois une autre situation de communication clinique spécifique en matière de santé, c'est l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Les objectifs du cours sont définir une mauvaise nouvelle, décrire l'impact d'une bonne information sur les réactions émotionnelles du patient, décrire les réactions émotionnelles des médecins suite à l'annonce, et enfin, décrire une procédure pour annoncer une mauvaise nouvelle. Dans la littérature scientifique, beaucoup de recherches concernent l'annonce d'une mauvaise nouvelle.

Déjà, c'est quoi la définition d'une mauvaise nouvelle ? Il s'agit d'un concept qui renvoie à un jugement de valeur porté par le patient sur une situation perçue comme sans espoir, menaçant son bien-être physique et ou mental, risquant de bouleverser son quotidien et l'obligeant à s'orienter vers de nouveaux choix de vie. La vie avant l'annonce de cette mauvaise nouvelle est différente de la vie après l'annonce. La mauvaise nouvelle se définit a posteriori lorsqu'elle entraîne un déficit cognitif, comportemental ou émotionnel chez le patient, qui persiste après l'annonce.

Exemple de mauvaise nouvelle, maladie à pronostic défavorable comme le cancer, une amputation, l'annonce d'un handicap important lors d'une naissance et autres. L'évaluation d'une mauvaise nouvelle est subjective, elle est faite par le médecin et son patient. Une annonce de mauvaise nouvelle est inévitablement un traumatisme.

Par exemple, l'idée d'avoir un cancer induit une détresse psychologique. Le sujet est confronté à son futur et sa durée de vie. Une transmission empathique d'une mauvaise nouvelle peut réduire le risque de traumatisme secondaire.

Quels sont les objectifs de l'annonce ? Réduire, comme on a dit, le risque de traumatisme et de souffrance psychique du patient et transmettre des informations qui permettent une adaptation et une adhésion de celui-ci à son traitement. Quel est l'impact émotionnel de l'annonce d'une mauvaise nouvelle ? D'abord, quelles sont les réactions émotionnelles du patient ? Des facteurs liés à la situation et à la personnalité du malade influencent ces réactions. En général, l'anxiété des patients diminue après un entretien avec le médecin.

Les défenses psychologiques ont pour objectif de réduire l'intensité, la fréquence et la durée de la souffrance émotionnelle. Beaucoup de mécanismes de défense sont élaborés pour se protéger d'une réalité jugée trop douloureuse pour le malade. Les mécanismes de défense sont multiples et sans d'intensité variable.

Je vous demande de vous référer à vos cours de psychologie. De nombreuses classifications sont proposées des différents mécanismes de défense. Je vous ai donné ici un exemple sur le déni.

Le déni consiste à rejeter en totalité ou partiellement le contenu de l'information reçue et ses conséquences. Le patient réagit de telle sorte qu'il donne l'impression de ne pas avoir entendu l'annonce ou bien il va nier l'information médicale, évoquant une erreur médicale par exemple. Il existe un consensus selon lequel l'information devrait avoir au moins une fonction essentielle.

C'est réduire le sentiment pénible d'incertitude et l'anticipation. L'information peut corriger, dédramatiser le caractère létal associé souvent à une pathologie, par exemple le cancer, par une remise en question des croyances du malade. Les informations transmises ont également comme fonction d'améliorer la relation médecin-malade.

L'information a également comme fonction d'amener le malade à un traitement curatif ou palliatif susceptible de lui être bénéfique. Le médecin est tenu de transmettre une information claire et objective au patient tout en laissant la place à l'espoir. Et telle est la difficulté de l'annonce d'une mauvaise nouvelle.

Il est contraint d'endosser le rôle de messenger de mauvaise nouvelle. Donc c'est normal qu'il y ait des réactions émotionnelles face à l'annonce. D'abord la première réaction c'est la peur de l'annonce.

La peur de faire mal à son malade, la peur d'être tenu pour responsable, la peur de ne pas savoir transmettre l'information, d'être maladroit, la peur des réactions émotionnelles incontrôlables des patients et la peur d'exprimer ses propres émotions. La deuxième réaction émotionnelle des médecins c'est le sentiment d'échec, la culpabilité, la tristesse. Face à ces réactions émotionnelles les médecins développent aussi des mécanismes de défense.

Par exemple le mensonge. Le médecin dissimulera la découverte de métastases à son patient à un stade avancé de la maladie, souvent employé avec le prétexte de vouloir protéger son patient. La fausse réassurance, le médecin maintient le patient dans de faux espoirs.

La rationalisation, le médecin va adopter un discours scientifique usant deux mots techniques incompréhensibles pour le patient. La banalisation ou la distanciation, le soignant ne se focalise que sur la douleur physique du patient, négligeant totalement sa souffrance psychique. Et l'évitement qui est traduit par des comportements de fuite du médecin vis-à-vis de son patient.

Il va remporter par exemple la consultation d'annonce. J'ai choisi une procédure simple pour annoncer une mauvaise nouvelle, c'est la procédure BAD. C'est une procédure qui tient compte de la réalité clinique et qui inclut les techniques de base de la communication qu'on a vu ultérieurement.

Structurer d'abord l'entretien, transmettre les informations de façon claire et gérer les émotions. La chronique BAD correspond B pour Breaking Bad News, A pour Acknowledge Patients' Reactions et D pour Develop Plans for the Near Future. D'abord, Breaking Bad News, transmettre l'information.

Il faut d'abord se poser la question, que sait le patient sur sa maladie? Il est conseillé de demander au patient, pouvez-vous me dire brièvement ce que vous savez sur votre maladie, avant d'annoncer la mauvaise nouvelle. Les connaissances qu'ont le patient de leur maladie peuvent parfois être erronées. Il est fréquent que les expériences passées, par exemple une affection cancéreuse ayant touché un proche, aient généré des croyances diverses qui ne concordent pas toujours avec la réalité médicale.

Deuxièmement, annoncer. Je suis désolé et on annonce de façon claire. L'annonce permet de focaliser l'attention du patient sur ce qui va suivre.

Parfois le patient anticipe déjà la mauvaise nouvelle, il va vous dire est-ce que le cancer est revenu, est-ce que la tumeur est revenue? Il faut savoir que la transmission non-verbale, les techniques de communication non-verbales d'information, par son caractère hautement ambigu et donc potentiellement interprétable, peut entraîner un état de détresse. Donc là, les méthodes de communication non-verbales sont à éviter lors de l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Troisièmement, information claire et précise, comme on a dit tout à l'heure.

Keep it short and simple. La plupart des mauvaises nouvelles peuvent être annoncées brièvement et avec simplicité et clarté. Les médecins, en fait, qui parlent beaucoup et utilisent un langage compliqué, vont satisfaire davantage leurs propres besoins que ceux des patients.

Après, il faut donner un temps de pause au patient pour lui permettre de réagir et d'exprimer ses besoins immédiats et de lui permettre de réaliser la mauvaise nouvelle. En fonction de la réaction du patient, le médecin répondra plutôt à ses émotions ou à ses besoins d'information en utilisant soit la technique de gestion des émotions, soit la technique de réconfort. Le réconfort est important lorsqu'il est porteur d'espoir.

Mais si le réconfort est apporté précocement, les patients se trouvent privés du temps nécessaire pour prendre conscience de leur inquiétude et pour identifier les informations dont ils ont besoin dans l'immédiat. Il faut annoncer la stratégie thérapeutique à court terme, c'est-à-dire quelles sont les prochaines étapes. Le patient doit être informé des prochaines étapes.

Par exemple, en premier lieu, on doit opérer puis on décidera après des autres démarches. Fixer un rendez-vous et assurer sa disponibilité en cas d'urgence, c'est très important pour votre patient. Une consultation d'annonce a besoin de conditions matérielles précises.

Le rendez-vous doit être organisé sans mise en scène excessive pour éviter de majorer l'angoisse dans un délai acceptable en tenant compte du fait que la détresse psychique du patient et l'anticipation est une urgence. Proposer au patient s'il le souhaite d'être accompagné d'un proche. L'environnement doit être calme, pas de téléphone, pas de dérangement lors de l'entretien.

S'asseoir pour parler avec votre malade en face à face. Prendre le temps, c'est un entretien qui

doit être dédié spécifiquement à l'annonce et à la discussion. C'est un schéma qui résume la conduite à tenir devant une mauvaise nouvelle ou comment faire l'annonce d'une mauvaise nouvelle.

Je vous ai mis ici des exemples d'annonce d'une mauvaise nouvelle qu'on pourrait discuter lors des séances interactives. En conclusion, il n'y a pas une annonce mais une succession d'annonces parce qu'il s'agit d'un processus thérapeutique long et ce sont des annonces qui se font au rythme des patients. Je vous remercie.